

34 - Neuroleptiques et Antipsychotiques Pr BENALI

Chers étudiants, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le dernier cours attrait aux neuroleptiques et aux antipsychotiques. Je vous signale que pour le cours les hypnotiques et les neuroleptiques ainsi que les antipsychotiques, l'évaluation se fera comme pour l'ensemble des psychotropes par QCM.

Je serai très ravi de vous retrouver dans la séance interactive programmée le mardi à 14h30 et je serai disponible pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous l'avez bien constaté, mes objectifs pédagogiques restent pratiquement les mêmes et ils s'intéresseront à la définition d'un neuroleptique et d'un antipsychotique. Aux mécanismes d'action et la classification, aux indications, aux contre-indications et aux effets secondaires.

Et surtout la quatrième partie, qui me semble très importante et très intéressante, ce sont les modalités de prescription et de suivi des neuroleptiques et des antipsychotiques. Le plan du cours reste inchangé, c'est toujours les mêmes rubriques. Ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir apprendre et assimiler les différents cours sur les psychotropes.

Et pour les neuroleptiques et les antipsychotiques, qui seront définis dans une introduction, je citerai les enjeux de la question et les deux mécanismes d'action importants pour les neuroleptiques et les antipsychotiques. Savoir classer les neuroleptiques et les antipsychotiques et dire, bien évidemment, un mot sur les indications, les contre-indications, les effets secondaires. Et vous montrer comment prescrire un neuroleptique et comment suivre un patient sous traitement antipsychotique.

Le cours s'intitule Neuroleptiques et Antipsychotiques. Ce sont deux choses distinctes, mais l'ensemble signifie qu'il s'agit de psychotropes, psycholeptiques aux propriétés réductrices des troubles psychotiques. Donc rappelez-vous, les neuroleptiques et les antipsychotiques, ce sont des médicaments psychotropes, psycholeptiques, et qui ont des propriétés réductrices des troubles psychotiques.

Un peu dans le détail, et pour différencier c'est quoi un neuroleptique et c'est quoi un antipsychotique, c'est que le neuroleptique renvoie à un terme très ancien, c'est-à-dire à des médicaments qui sont très anciens et qui ont une action inhibitrice sur les excitations, les agitations et l'agressivité. Ils ont une action réductrice des états maniaques et des psychoses aiguës et chroniques et ont des effets neurologiques et neurovégétatifs très importants, tout simplement parce qu'ils ont une action sur les régions cérébrales sous-corticales. Ces neuroleptiques ont évolué et ont donné lieu à des neuroleptiques de deuxième génération qu'on appelle les antipsychotiques.

Cette dernière classe a une action sur la neurotransmission et réduit d'une manière significative les effets secondaires neurologiques qu'on rencontre avec le neuroleptique. La différence se situe à la fois en termes d'action ou de mécanisme d'action qui, pour le résultat,

c'est d'avoir moins d'effets secondaires neurologiques avec les antipsychotiques qu'avec les neuroleptiques. Cette question est importante tout simplement parce que pour les neuroleptiques et les antipsychotiques c'est une classe très hétérogène.

Les médicaments ont un profil d'action et de tolérance différent, en particulier neurologique. La possibilité de choix du médicament adapté est en rapport avec à la fois les caractéristiques individuelles des patients et des comorbidités associées. Ces médicaments ont des indications plus larges parce qu'ils dépassent le champ strict des psychoses.

Les deux médicaments neuroleptiques, c'est-à-dire les anciens molécules et les nouvelles molécules, ont un antagonisme dopaminergique qui s'intéresse ou qui intéresse les quatre voies dopaminergiques. Cet antagonisme dopaminergique explique les effets antipsychotiques, les effets extrapyramido et endocriniens. Le premier, c'est-à-dire antipsychotique, est un effet qui est recherché.

L'effet extrapyramidal et endocrinien étant des effets secondaires. En parallèle d'une action dopaminergique, ces molécules vont avoir des propriétés antagonistes à la fois sérotoninergiques, ce qui expliquerait les effets antipsychotiques. Sur les récepteurs antihistaminiques, nous aurons comme corollaire une sédation et une éventuelle prise de poids.

Les effets atropiniques seront en lien avec l'antagonisme des récepteurs anticholinergiques. Les troubles de la mémoire et les troubles moteurs seront liés à l'action antimuscarinique et l'hypotension orthostatique est en rapport avec l'antagonisme alpha-adrénalytique. Ce schéma explique comment les neuroleptiques dits classiques, vont bloquer les récepteurs dopaminergiques des deux.

Les quatre voies que j'ai citées sont la voie mésolimbique, la voie nigrostriée, la voie tubero-infundibulaire et la voie mésocorticale. Au regard de chaque voie, vous aurez à titre d'exemple pour la voie mésolimbique, une réduction des symptômes positifs. Face à la voie tubero-infundibulaire, vous aurez ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie.

Alors que les symptômes extra-péramido et les troubles moteurs sont en lien avec le blocage des récepteurs dopaminergiques des deux au niveau de la voie nigrostriée et l'aggravation des symptômes négatifs et cognitifs est en rapport avec la voie mésocorticale. Pour les antipsychotiques, nous aurons un antagonisme double à la fois dopaminergique comme les neuroleptiques sur lequel se rajoute un effet séro-toninergique. Et au regard de chaque voie, vous avez la symptomatologie ou l'effet qui est recherché et on citera principalement qu'au niveau de la voie mésocorticale, il y a une amélioration des symptômes négatifs et cognitifs.

C'est ainsi que les antipsychotiques vont bien évidemment réduire les symptômes positifs, améliorer les symptômes négatifs, mais diminuent considérablement l'hyperprolactinémie et les syndromes ou les symptômes extra-péramido. Donc ce qui explique leur usage très fréquent face à cette efficacité comparable aux précédentes, c'est-à-dire les neuroleptiques,

mais à une tolérance meilleure par rapport aux premiers. Les neuroleptiques et les antipsychotiques sont administrés soit par voie orale ou intramusculaire, notamment dans les situations d'urgence ou pour les formes à action prolongée.

La résorption se fait par voie digestive et elle est variable. Les produits sont très lipophiles et subissent un catabolisme hépatique avec un effet de premier passage important. Les métabolites sont nombreux et certains majeurent les effets de la molécule mère comme l'effet nausée.

Ils sont éliminés par voie urinaire et biliaire et les neuroleptiques d'action prolongée, ce qu'on appelle les neuroleptiques NENAP ou les antipsychotiques à action prolongée, c'est-à-dire les APAP, se libèrent lentement par hydrolyse et agissent pendant plusieurs semaines. On donne une injection par mois et on aura un effet durant 3 à 4 semaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les neuroleptiques et les antipsychotiques, on a principalement un antagonisme et d'autres actions communes avec le blocage d'autres récepteurs ce qui explique, bien évidemment, pour chaque molécule, un certain nombre d'effets secondaires.

Cette classe thérapeutique est très hétérogène et il existe plusieurs molécules et pour pouvoir les classer, on va faire appel à une classification selon la structure chimique. Pour les neuroleptiques, c'est-à-dire les médicaments de première génération, ce sont des molécules anciennes on a les phénothiazines, les butyréphonones et les benzamides. Ceux qui sont marqués en gras sont les plus utilisés au Maroc, je citerai par exemple la levomépromazine, le nozinant ou l'alopéridol, l'aldol.

Les médicaments de deuxième génération qu'on appelle antipsychotiques, on a quatre classes marquées essentiellement par les thioxantines, le clopixol qui n'existe pas au Maroc. On a les dibenzodiazépines, la clozapine commercialisée sous le nom du Leponex les dibenzoxazépines et on a soit la loxapine, le loxapac qui n'existe pas au Maroc, mais on a l'olanzapine, le ziprexa et on a d'autres molécules qui ont d'autres mécanismes d'action tout à fait différents des antipsychotiques et on citera notamment l'aripiprazole, l'abilify ou la paliperidone. Dans la pratique courante et selon la sémiologie clinique on aura tendance à donner des médicaments selon le type d'action de ces molécules.

C'est ainsi que la deuxième classification va faire appel aux polarités bien évidemment des neuroleptiques et des antipsychotiques entre les sédatifs les intermédiaires et les incisifs. Donc on aura quatre classes les neuroleptiques sédatifs et on citera par exemple la levomipromazine, le nozinant et on a les neuroleptiques incisives c'est ceux qui ont une action sur les symptômes psychotiques, notamment le délire et les hallucinations et nous avons les neuroleptiques atypiques, qu'on appelle antipsychotiques qui ont moins d'effet secondaire et qui ont surtout un effet anti-déficitaire et on citera à titre d'exemple le risperdal le ziprexa, la bilifaï ou le xaroquel les neuroleptiques à action prolongée soit les NAP ou les ZAPAP ça dépend ce qu'il s'agit d'une ancienne molécule comme le piportil LP4 ou d'une nouvelle molécule comme le zypadéra, le risperdal constat ou le xéplir les neuroleptiques et les antipsychotiques ont des

indications très larges mais ce sont les médicaments de première intention pour la schizophrénie ils ont une efficacité sur les symptômes positifs une efficacité supérieure sur les symptômes négatifs et timides notamment pour les antipsychotiques et une action variable d'une molécule à l'autre ces médicaments sont indiqués pour les délires chroniques non schizophréniques les neuroleptiques et les antipsychotiques sont aussi indiqués dans le cas des troubles de l'humeur si on a un trouble bipolaire, les antipsychotiques en particulier ont une action soit antimaniaque soit timorégulatrice sont largement utilisés dans les dépressions avec symptômes psychotiques en association avec les antidépresseurs la risperidone est utilisée d'une manière particulière en cas d'agressivité chez les patients porteurs de maladies d'Alzheimer ou chez les enfants plus de 5 ans ayant des troubles du comportement pour ces deux indications, il ne faut pas dépasser 6 semaines la clozapine est utilisée dans le cadre de la schizophrénie résistante ou dans le cadre des symptômes psychotiques de la maladie de Parkinson d'autres indications sont marquées essentiellement par les troubles obsessionnels compulsifs la maladie de Gilles de la Tourette dans l'insomnie rebelle ou face au syndrome confusionnel grave les contre-indications des neuroleptiques et antipsychotiques sont résumées ou réunies dans ce tableau les contre-indications absolues sont liées au risque de glaucome angle fermé au risque de rétention d'urine ou face à l'existence d'une hypersensibilité bien évidemment il y a d'autres précautions d'emploi et je citerai notamment l'épilepsie surtout quand on veut utiliser la clozapine ou chez un patient qui a un sevrage à l'alcool au barbiturique et au benzodiazépine pour le chapitre des effets indésirables des neuroleptiques et antipsychotiques comme vous pouvez le constater face à la catégorie des effets indésirables il y a ce qu'on appelle la candida tenir ou le traitement correcteur et l'une des pathologies que j'ai citées tout à l'heure étant une sémiologie neurologique extrapyramidale qui peut se décliner en un syndrome hyperkinétique ou face à l'existence de dyskinésie aiguë ou tardive les dyskinésies aiguës sont généralement le trismus les troubles de la déglutition ou tardive, une hypertonie et du mouvement anormaux involontaire on peut avoir aussi un syndrome parkinsonien et une épilepsie face à l'abaissement du seuil épileptoché quand on a une sémiologie pareille il faut prescrire un antiparkinsonien et traiter les dyskinésies aiguës ce qui est important c'est surveiller l'apparition de mouvements répétitifs quand vous aurez un patient sous antipsychotique ou neuroleptique il faut redouter et surveiller l'apparition de mouvements répétitifs et prévenir le médecin pour une modification ou un arrêt du traitement le deuxième paragraphe est les pathologies endocriniennes on peut avoir, vous l'avez vu tout à l'heure par rapport au mécanisme d'action des antipsychotiques, une hyperprolactinémie marquée surtout par la galactorée et la ménorrhée, une prise de poids avec une augmentation de l'appétit et une diminution de l'activité physique et une diminution du métabolisme les patients risquent de gagner en poids et de tomber sur le surpoids ou l'obésité deux autres pathologies à redouter quand on prescrit ce médicament ce sont les dyslipidémie et le diabète ce qui est important c'est la surveillance de la courbe du poids il faut noter aussi que chez la femme enceinte il faut prescrire un test de grossesse parce que cela implique certaines règles de prescription quand la femme est enceinte les effets anticholinergiques sont marqués par l'existence d'une sécheresse de la bouche d'une constipation, trouble de la miction trouble de l'accommodation ou un syndrome confusionnel il

faut donner un traitement correcteur malheureusement le sulfarlem n'existe pas au Maroc mais on peut le ramener de l'étranger quand on a une sécheresse buccale, quand on a une sécheresse oculaire il y a des larmes artificielles qu'on peut trouver en pharmacie et face à la constipation il faut faire appel à des mesures diététiques un régime alimentaire riche en fibres et donner en cas de nécessité des laxatifs selon l'intensité de la constipation le quatrième point étant les effets cardiovasculaires avec surtout une hypotension orthostatique et un risque d'allongement de l'espace cuté le traitement correcteur étant le par exemple le guterran il faut prendre le pouls et la tension debout et assis pour surveiller d'éventuelles hypotensions orthostatiques il faut apprendre à la personne à passer de la position couché en position debout en deux temps en restant assis quelques minutes au bord du lit et préconiser de ne pas se pencher brutalement en avant votre rôle aussi sera très important en ayant à l'esprit une urgence qui risque de mettre en jeu le pronostic vital du patient c'est le syndrome malin des neuroleptiques quand on a un patient sous neuroleptique et sous antipsychotique et on assiste à une hyperthermie majeure à l'existence d'une rigidité extra pyramidal et musculaire, un collapsus cardiovasculaire et parfois des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'à des convulsions ou des comas et quand on fait un bilan et on trouve une élévation des CPK ou une cytolyse hépatique et une hyperleucocytose il faut penser au syndrome malin des neuroleptiques et bien évidemment penser à arrêter le traitement et transférer le patient en réanimation donner un traitement symptomatique en préconisant une réhydratation et une correction des troubles hydroélectrolytiques et donner un traitement spécifique qui est un agoniste dopaminergique la bromoxyriptine ou un agoniste cholinergique le dentrolène quant à la partie des modalités de prescription des neuroleptiques et antipsychotiques il est à signifier et à dire que les médecins généralistes peuvent bien évidemment prescrire ces médicaments et avant toute prescription il faut faire appel à ce qu'on appelle une approche non pharmacologique qui est basée sur l'éducation du patient sur un examen somatique rigoureux et caractériser la nature de la symptomatologie de troubles pour lequel est indiqué un neuroleptique ou un antipsychotique Le choix de la molécule dépend bien évidemment de la cible principale soit on veut soigner le délire donc on va choisir un traitement incisif soit on veut traiter de l'anxiété donc on va préconiser un traitement sédatif la voie d'administration la réponse au traitement déjà préconisé antérieurement les effets secondaires éventuels à la volonté du patient, c'est à dire qu'est-ce qu'il préfère comme médicament et à la prédominance de certaines manifestations cliniques Le choix dépend bien évidemment de tout ce qu'on avait vu par rapport à ces deux grandes classes thérapeutiques c'est qu'il faut privilégier en première intention les antipsychotiques dites de deuxième génération parce qu'ils ont un meilleur rapport efficacité-tolérance et les neuroleptiques classiques, il faut le dire gardent un intérêt lorsqu'on cherche une action sédatrice ou un contrôle comportemental et notamment ils sont prescrits et préconisés dans la dimension de l'urgence la posologie des médicaments est généralement progressive et elle est en rapport avec l'efficacité et la tolérance je citerai par exemple le nozinant qui est un médicament neuroleptique très sédatif on peut donner 200 à 300 mg mais on a des patients qui juste à 50 à 100 mg sont généralement apaisés, moins anxieux et moins agités le risperdal est préconisé dans les doses entre 4 et 8 mg par jour l'halopéridol qui existe sous forme de gouttes est préconisé et prescrit à une posologie entre 5 et

15 mg le ziprexa qui est l'holonzapine entre 5 et 20 mg par jour la réponse thérapeutique est en rapport avec l'efficacité et la tolérance du médicament il y a une évaluation régulière de la réponse au traitement qui est une évaluation purement clinique et si aucune réponse n'est obtenue après 4 à 6 semaines il est conseillé de changer de molécule on surveille les éventuelles manifestations notamment neurologiques extrapyramidales la pression artérielle, le transit intestinal la température et les paramètres métaboliques la glycémie, les lipides mais surtout le poids et le périmètre ombilical encore une fois un tableau résume la surveillance métabolique des antipsychotiques de deuxième génération pourquoi j'ai mis les antipsychotiques ? parce que c'est les médicaments les plus largement utilisés depuis pratiquement deux décennies cette surveillance se fait soit à T0 c'est à dire au départ et elle englobe les 5 paramètres le poids, le périmètre ombilical la glycémie agent, un bilan lipide et une pression artérielle le poids et la taille bien évidemment il faut faire attention surtout le premier mois, le deuxième mois et avec la fréquence tous les trimestres il faut prendre le poids et le périmètre et surtout l'IMC le périmètre ombilical est pris bien évidemment au début du traitement le deuxième mois on refait un bilan bien évidemment on a une glycémie agent, un bilan lipide et on prend la pression artérielle tous les trimestres il faut revoir l'IMC du patient et tous les ans une glycémie agent et la pression artérielle et un bilan lipide tous les 5 ans ce sont généralement les règles de surveillance d'un patient sous antipsychotique de deuxième génération la durée du traitement antipsychotique est variable selon la symptomatologie elle est de 6 à 12 mois face à un état psychotique aigu afin de prévenir le risque de rechute elle est de 1 à 2 ans quand on a un épisode psychotique qui est lié à la maladie schizophrénique quand la schizophrénie est confirmée et qu'il y a plusieurs épisodes féconds il faut poursuivre le traitement au minimum pendant 5 ans il faut signaler qu'il y a nécessité d'une prudence avant d'interrompre le traitement tout simplement pour ne pas assister à un risque de rechute ou à une réémergence de manifestations symptomatiques c'est ainsi que l'arrêt du traitement se fait de manière progressive afin de prévenir le risque de rechute et la réémergence de manifestations symptomatiques délirantes ou hallucinatoires il ne faut pas diminuer la posologie d'un traitement efficace avant 3 mois de stabilité et insister sur l'observance thérapeutique qui fait appel à l'éducation du patient et l'implication de son entourage L'essentiel de la modalité de prescription c'est que l'initiation d'un traitement neuroleptique ou antipsychotique doit être adaptée à la fois à la sébiologie clinique aux symptômes répandérants est-ce qu'on a plus de symptômes positifs est-ce qu'on a plus de symptômes négatifs et bien évidemment à l'évolution de la maladie la posologie est croissante elle est en rapport avec l'efficacité du traitement et sa tolérance et j'insiste encore une fois sur l'information du patient sur le travail de l'observance thérapeutique sur la nécessité des mesures psychosociales des psychothérapies et surveiller les effets secondaires bien évidemment cette surveillance favorise plus l'observance thérapeutique cette diapo n'est pas une répétition mais surtout le résumé de ce que vous devez savoir par rapport à la prescription des neuroleptiques et antipsychotiques à savoir un examen clinique préalable un bilan préthérapeutique une surveillance clinique de l'efficacité et de la tolérance en insistant surtout sur la température la pression artérielle, le transit intestinal les mouvements anormaux, le poids et l'IMC et la posologie elle est variable elle est individuelle et progressive et si on veut l'arrêter c'est sur plusieurs mois les différentes

formes disponibles ce sont les comprimés, des gélules, des gouttes, des comprimés horodispersibles et la prise se fait généralement en 2 à 3 prises quotidiennes voire une seule pour les antipsychotiques de 2ème génération. Les formes injectables ont un effet immédiat dans les situations d'urgence le plus souvent comme le nausinant par exemple et un effet retard et prolongé quand il s'agit des neuroleptiques à action prolongée ou des antipsychotiques à action prolongée ce que j'ai appelé tout à l'heure les NAP et les APAP. L'avis d'un psychiatre est demandé quand le traitement est insuffisamment efficace et ou mal toléré quand il y a une survenue d'événements intercurrents ou quand vous êtes dépassé par la situation. En conclusion différentes classes de neuroleptiques et antipsychotiques sont commercialisées. Les approches non pharmacologiques doivent être systématiquement associées. Il importe d'expliquer aux patients les modalités de prise de son médicament, être attentif à l'observance qui est liée à l'efficacité et à la tolérance, être attentif au vécu de la maladie à la fois du patient mais aussi de son entourage. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage dans toute votre préparation mais aussi dans toute votre vie étudiante avec le plaisir de vous retrouver le mardi pour la première séance interactive pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci.